

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage – Hanche

Contenu : Dre. Sophie Merckaert, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)



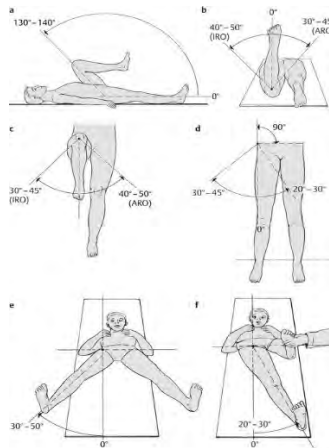
UNIL | Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u>	<u>Description</u>	<u>Photos ou illustration</u>
a. Présentation clinique fréquente indiquant la réalisation du test	a. Position et action du patient	
b. Signification de la positivité	b. Action de l'examineur	
c. Commentaires	c. Pièges à éviter	

GONIOMETRIE HANCHE

- a. Lors de tout examens de la hanche après avoir écarté une fracture où une épiphysiolyse
- b. Bilan des amplitudes articulaires dans le plan sagittal/frontal et horizontal
- c. Se référer au skills locomoteur B3.8 : Goniomètre



- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen*
- b. L'examinateur effectue flexion/extension de hanche

Rotation interne et externe de la hanche

Abduction/Adduction
- c. Rester dans l'axe lors des mouvements. Ne pas confondre rotation interne et externe

*Les rotations se font en décubitus ventral et dorsale (b, c)
*L'extension se mesure décubitus ventrale ou latérale



1. flexion



2. extension



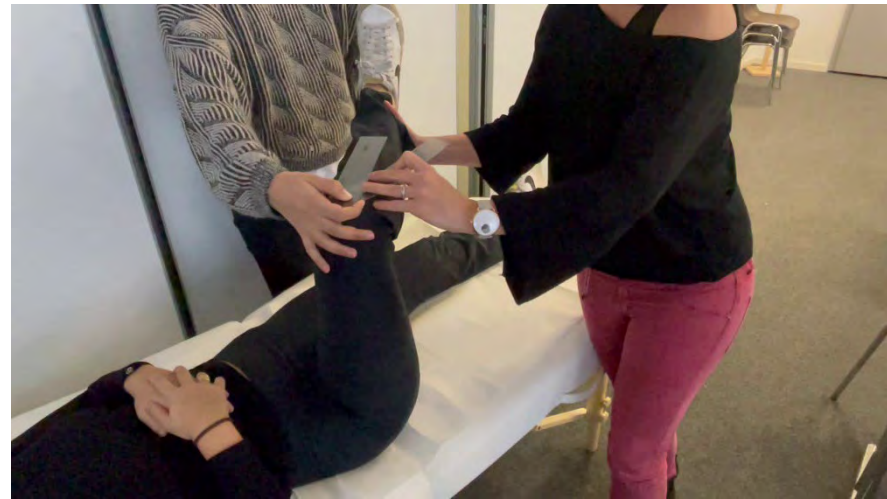
3. abduction



5. rotation interne



4. adduction

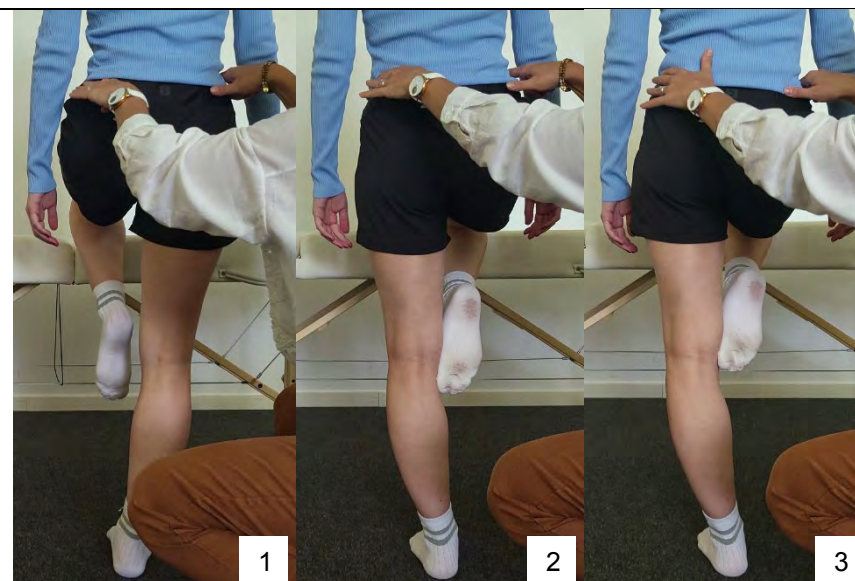


6. rotation externe

Test de Trendelenburg

- a. Boiterie sur faiblesse des muscles abducteurs de hanches (boiterie de Trendelenburg)
- b. Dysfonctionnement des abducteurs de hanche principalement du m. moyen fessier.
- c. Ne pas faire ce test si on suspecte une fracture ou épiphysiolyse

- a. Patient debout qui effectue un appui monopodal pour chaque côté. L'appui monopodal doit être maintenu pour 15-20 secondes.
- b. Examineur se positionne derrière le patient observant l'inclinaison du bassin pour chaque côté
- c. Le test est positif si le côté du bassin où le MI est surélevé s'abaisse. Ceci signifie que les muscles abducteurs de hanches du côté où le MI est en appui n'arrivent pas à équilibrer le bassin dans le plan horizontal = faiblesse des abducteurs de la hanche



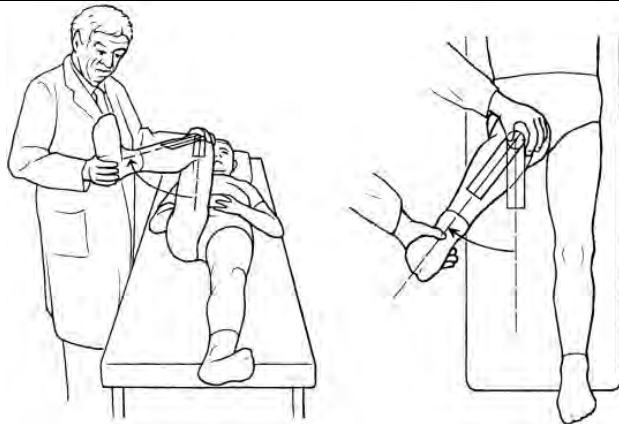
Légende :

- 1) lever le pied gauche pour tester le moyen fessier de la hanche droite
- 2) lever le pied droit lever le pied droit pour tester le moyen fessier de la hanche gauche
- 3) lorsque le test est positif : le bassin bascule parce que le m. moyen fessier du côté gauche est trop faible pour maintenir le bassin en place

**Test de FADIR = Impingement
test Flexion-Adduction-Internal
Rotation**

- a. Douleurs inguinales, douleurs de la hanche
- b. Un test positif nous oriente vers une pathologie de la hanche de type **conflit** qui nécessite d'exclure des **lésion intra-articulaires** (lésion labrum etc.)

- a. Le patient est en décubitus dorsal sur table d'examen
- b. La jambe affectée est mobilisée passivement par l'examineur. Mouvement de flexion de hanche à 90° avec genou fléchi à 90° puis il fait progressivement une rotation interne et adduction de la hanche combinée.
- c. Faire le test de manière trop doux



Test de FABER (Patrick test)

Flexion-Abduction-External Rotation

- a. Douleur dans la région de l'articulation de la hanche (pli de l'aîne) ou région de la sacro-iliaque
- b. Douleur dans la région du pli de l'aîne lors de l'exécution du test : suspicion pathologie intra-articulaire de la hanche
Douleur dans la région de la sacro-iliaque laisse suspecter une pathologie de cette articulation
- c. Ce test est en effet utilisé pour rechercher soit une pathologie dans la région de l'articulation de la hanche (douleur déclenchée au niveau du pli de l'aîne) et de l'articulation sacro-iliaque

- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen
- b. L'examineur se met au bord de la table du côté de la hanche à examiner. Avec une main il stabilise le bassin et avec l'autre main il amène la hanche passivement en **Flexion AB**duction et **Rotation Externe**.
Le test est positif pour la hanche si une douleur est ressentie au niveau du pli de l'aîne
Le test est positif pour l'articulation sacro-iliaque si une douleur est ressentie à ce niveau.
- c. Compensation du patient en basculant son bassin

FABER



Cette image illustre la position de la hanche après les mouvements de flexion, d'abduction et de rotation externe



Pour éviter que le patient bouge son bassin, l'examineur met une pression avec sa main au niveau de l'épine iliaque ce qui plaque le bassin contre le lit d'examen

Signe de Drehmann

- a. Douleur de hanche
 - b. Un signe de Drehmann positif doit laisser suspecter une épiphysiolyse ou une lésion au niveau du col fémorale (Ostéoarthrite, cal vicieux)
- a. Patient en décubitus dorsal sur table d'examen
 - b. L'examineur se met au bord de la table du côté de la hanche à examiner. Il effectue un mouvement de flexion de la hanche, genou fléchi à 90°. Le test est positif si la hanche part en rotation externe lors de la manœuvre.
 - c. Rester dans l'axe sagittal du patient



flexion normale de la hanche



lorsque le test est positif

Thomas test

- a. Boiterie, flessum de hanche
- b. Contracture du muscle iliopsoas ou rétraction capsuloligamentaire de l'articulation coxofémorale

- a. Patient en décubitus dorsal
- b. L'examineur fléchit passivement la hanche d'un côté jusqu'à avoir le rachis lombaire à plat sur la table d'examen. Il observe la hanche controlatérale qu'il faut rester complètement étendue. Si cette dernière se met en flexion progressive, le test est positif

The Thomas test



lorsque le test est négatif



lorsque le test est positif

Test de roulement (Rolling)

a. Boiterie d'épargne de la hanche avec des douleurs associées et suspicion de pathologie intraarticulaire (arthrite, fracture du col)

b. Un test positif doit faire exclure une arthrite septique, inflammatoire ou encore une fracture du col (plus fréquent chez personne âgés)

- a.** Le patient est en décubitus dorsal avec la hanche étendue.
- b.** L'examineur place ses mains sur le membre et fait rouler la hanche en rotation interne et externe tout en appréciant la résistance. Une douleur de hanche avec ce manœuvre est compatible avec une arthrite septique/inflammatoire en cas de symptômes associée ou avec une fracture du col du fémur ou pertrochanterienne chez la personne âgée.



<u>Salut Coxal (test de Stinchfield)</u> a. Suspicion de lésion dégénérative (Coxarthrose) b. Un test positif (douloureux) fait suspecter de l'arthrose	a. Le patient est en décubitus dorsal sur table d'examen b. Le patient effectue une surélévation de son membre inférieur avec genou en extension contre résistance de l'examineur	 Légende : flèche rouge : mouvement de l'examineur flèche verte : mouvement du patient
---	---	--